

Resultaten onderzoek: Welke uitkomsten zijn belangrijk voor patiënten bij het maken van een behandelkeuze?

Als u ziek bent, wilt u misschien van alles over uw ziekte weten. U zoekt bijvoorbeeld naar de behandelingen die mogelijk zijn en wat er dan gedaan wordt. Maar om met die informatie de juiste behandeling te kiezen, dat is best moeilijk.

Kiezen gaat makkelijker met 'uitkomst-informatie'. Dat is informatie over de resultaten van een behandeling. Bijvoorbeeld wat de kans is op pijn na een behandeling. Om beter te weten welke uitkomst-informatie belangrijk is voor patiënten, hebben wij een vragenlijst uitgezet via verschillende patiëntenverenigingen/organisaties. In deze vragenlijst is aan patiënten is gevraagd welke uitkomst-informatie voor hen belangrijk is bij het maken van een behandelkeuze. In dit verslag beschrijven we de resultaten.

Inleiding:

Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt uitkomst-informatie verzameld door middel van een scorekaart. De scorekaart bevat alle uitkomsten die belangrijk wordt geacht voor een specifieke aandoening. Het doel van het verzamelen van uitkomst-informatie is driedelig: transparantie in kwaliteit van zorg naar de buitenwereld (1), identificeren van verbeterpotentieel (2) en gebruiken van uitkomst-informatie in de spreekkamer, bijv. voor het maken van een behandelkeuze (3).

De scorekaarten worden opgesteld door verbeterteams, waarbij elk ziekenhuis één verbeterteam per aandoening heeft. Het streven is om in ieder verbeterteam een patiënt aan tafel te hebben (Santeon, 2020). De patiënt heeft hierdoor de mogelijkheid om mee te praten over welke uitkomsten belangrijk zijn, en waar de zorg voor deze aandoening nog verbeterd kan worden. In de praktijk zit er bij veel verbeterteams een patiënt aan tafel, maar is er ook een aantal teams waarbij het betrekken van patiënten moeilijk blijkt (van der Nat & Garvelink, 2021). In deze teams kiezen de zorgverleners welke uitkomsten zij denken dat belangrijk zijn voor de patiënten met die aandoening. Het is daarom onduidelijk in hoeverre de uitkomst-informatie die wordt gemeten daadwerkelijk aansluit bij de ervaringen en informatiebehoeften van patiënten.

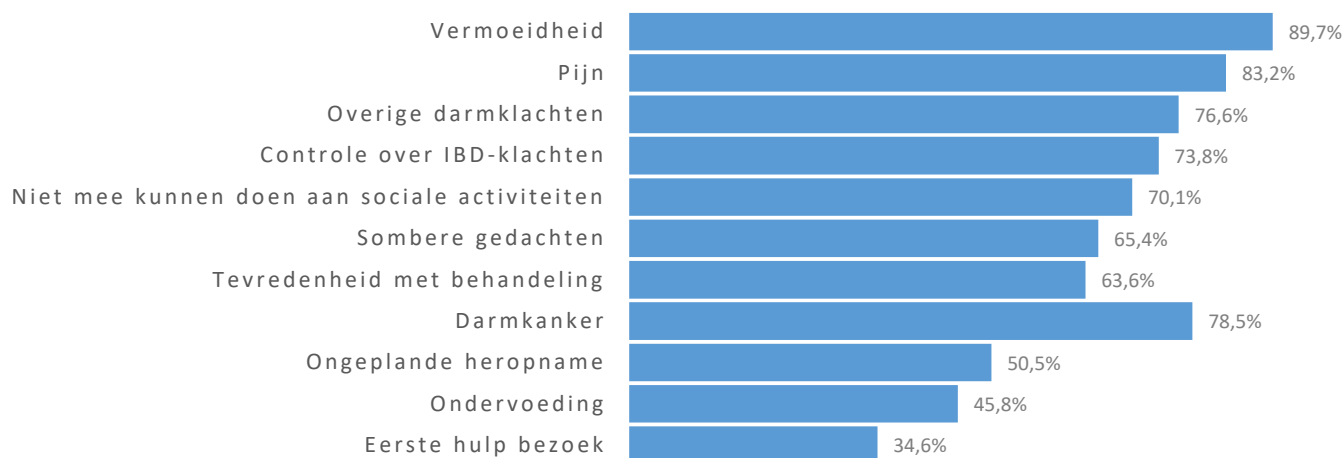
Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of de uitkomsten die onderdeel uitmaken van de Santeon scorekaarten aansluiten op de informatiebehoeften van patiënten. Hiervoor hebben we voor drie verschillende aandoeningen (Inflammatoire Bowel Disease (IBD), prostaatkanker en longkanker) aan patiënten gevraagd hoe belangrijk zij informatie over bepaalde uitkomsten vinden voor het maken van een behandelkeuze, en of ze deze uitkomsten alleen willen weten of ook zouden willen bespreken met hun zorgverlener. We zullen de resultaten hieronder toelichten.

Resultaten:

Over het geheel gezien sluiten de uitkomsten van de scorekaarten goed aan op de informatiebehoeften van patiënten. De meeste uitkomsten worden door patiënten als (zeer) belangrijk gescoord.

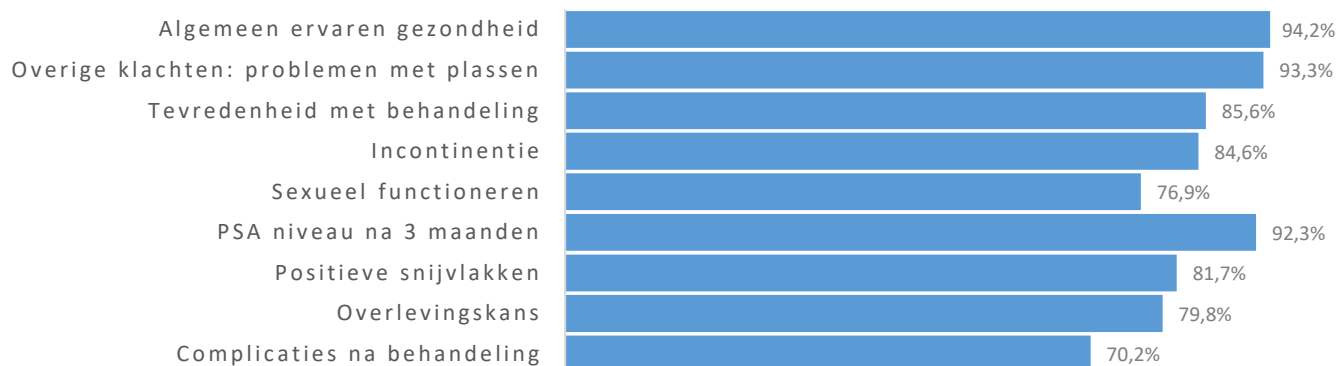
Van alle uitkomsten die worden verzameld voor IBD-patiënten worden pijn en vermoeidheid het vaakst als (zeer) belangrijk gescoord (zie figuur 2). Voor kankerpatiënten zijn bijna alle uitkomsten (zeer) belangrijk voor het maken van behandelkeuzes (zie figuur 3 en 4). Bij longkankerpatiënten wordt 'hoesten'

als het minst belangrijk bestempeld, namelijk 65.3% van de patiënten geeft aan dat dit een belangrijke uitkomst is (zie figuur 3).



Figuur 2 | Percentage IBD-patiënten dat een uitkomst als (zeer) belangrijk heeft bestempeld

Opvallend om te zien is dat IBD-patiënten ten opzichte van long- en prostaatkanker minder uitkomsten als 'belangrijk' bestempelen voor het maken van behandelkeuzes. Dit kan komen doordat IBD-patiënten over het algemeen minder behandelkeuzes hoeven te maken als ze eenmaal een behandeling hebben gevonden die goed aanslaat, of omdat ze minder geïnteresseerd zijn in gemiddeldes, aangezien IBD-symptomen en behandelingen heel erg kunnen verschillen per patiënt.

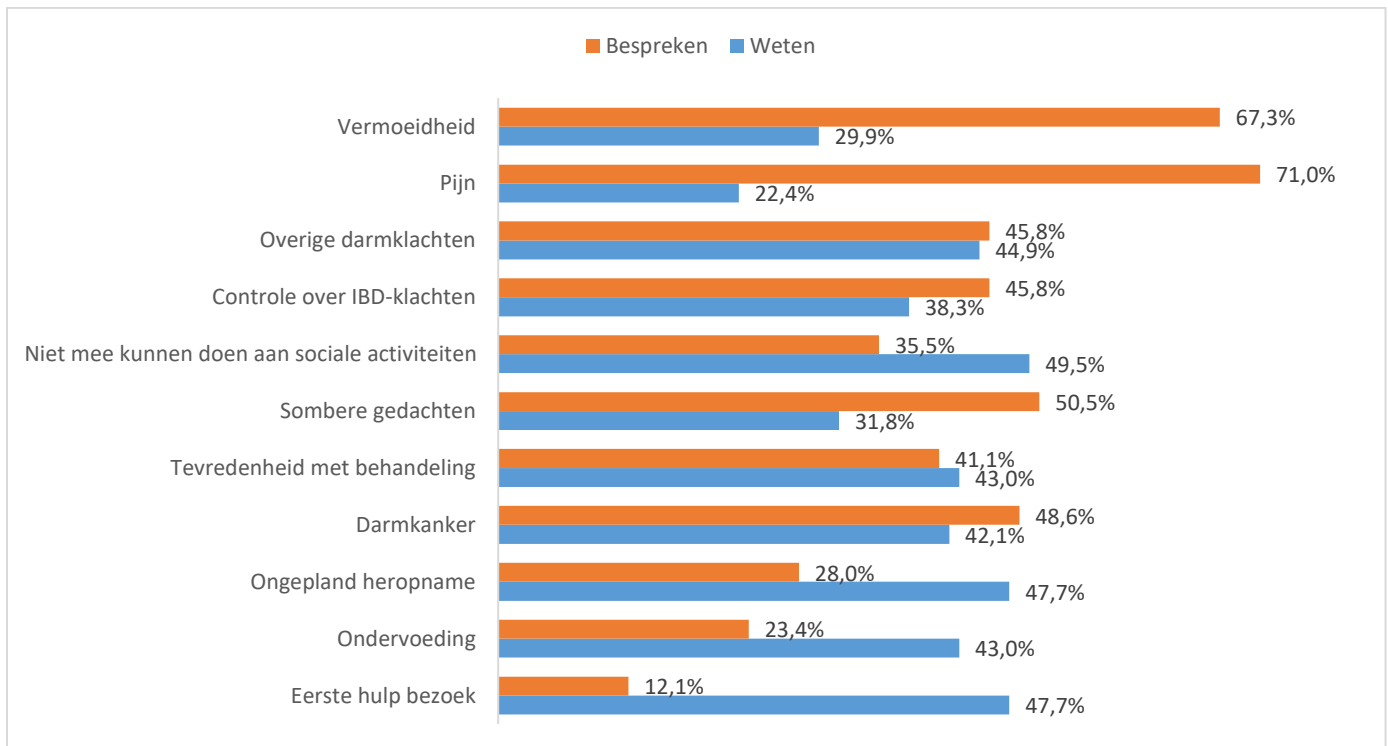


Figuur 3 | Percentage prostaatkankerpatiënten dat een uitkomst als (zeer) belangrijk heeft bestempeld

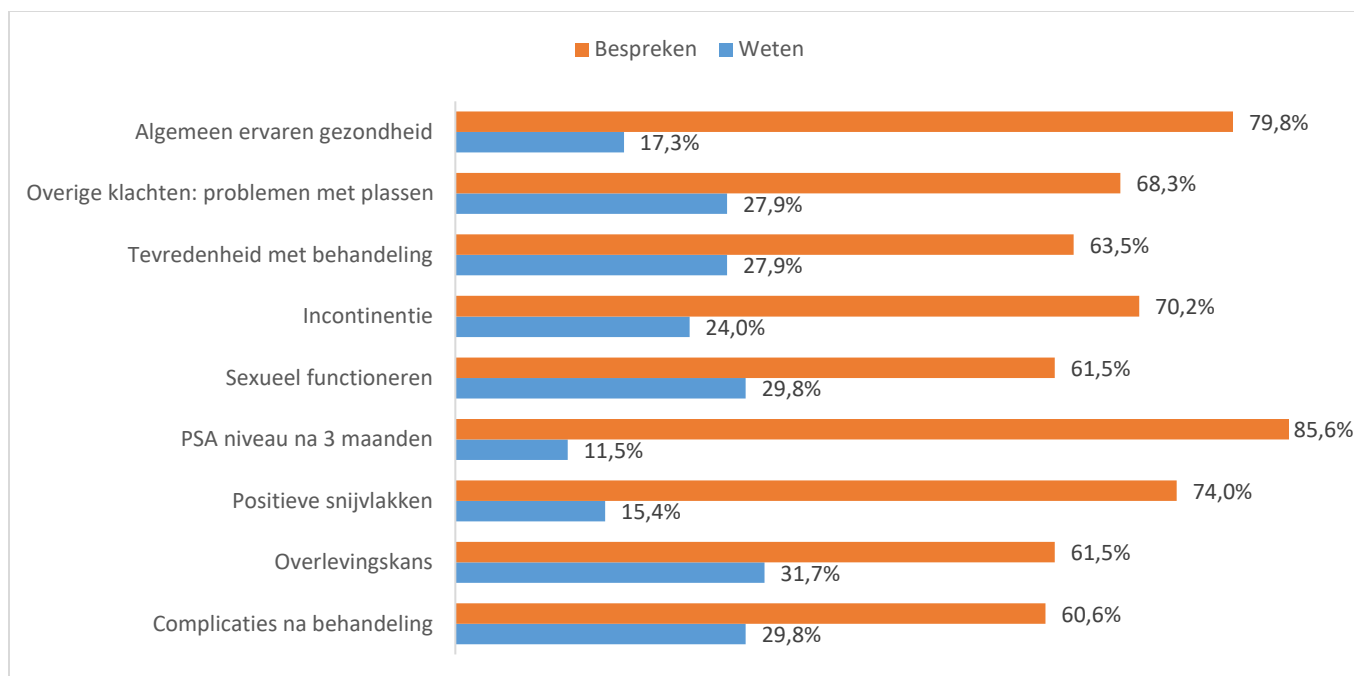


Figuur 4 | Percentage longkankerpatiënten dat een uitkomst als (zeer) belangrijk heeft bestempeld

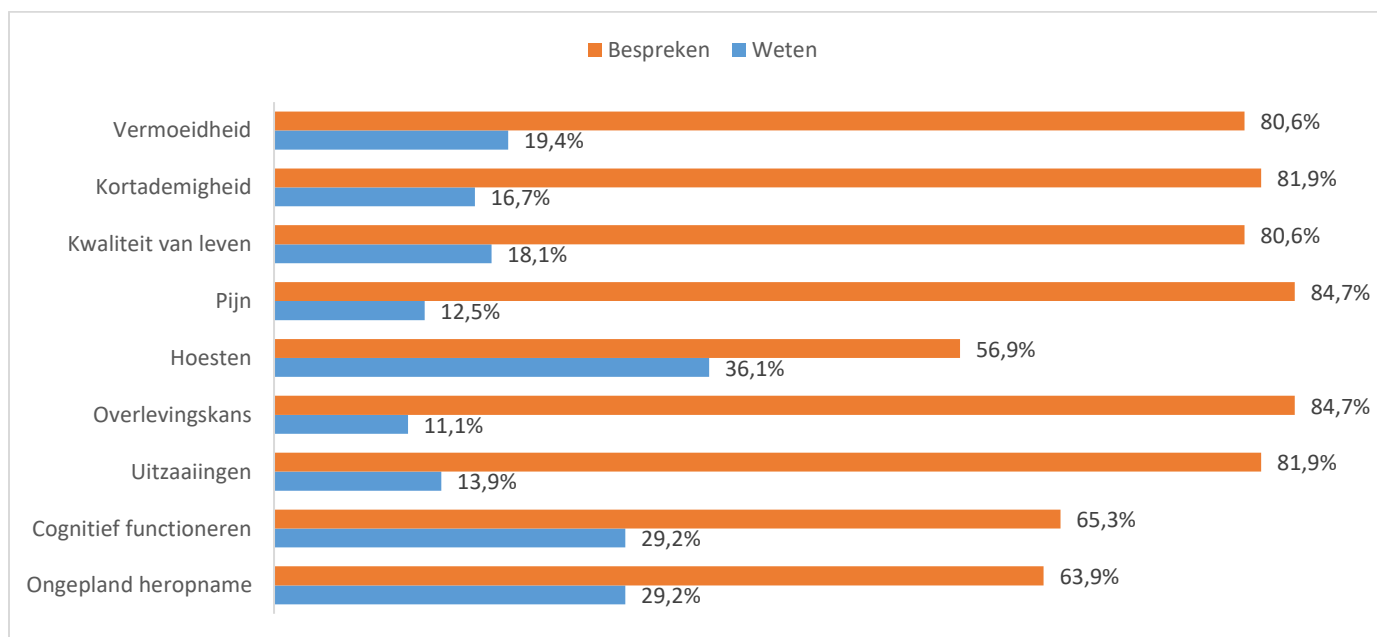
Daarnaast zien we eenzelfde soort verschil tussen de aandoeningen als we kijken naar hoeveel patiënten een uitkomst alleen willen weten of ook willen bespreken met hun zorgverlener. Over het algemeen willen de meeste kankerpatiënten de uitkomsten ook bespreken met hun arts, terwijl veel IBD-patiënten het voldoende vinden om er alleen van te weten. Dit verschil kan komen door verschillen in zelfmanagement tussen deze chronische en niet-chronische aandoeningen, waarbij chronisch zieke patiënten meer gewend zijn om met hun eigen aandoening om te gaan en informatie tot zich te nemen.



Figuur 5 | Percentage IBD-patiënten dat een uitkomst alleen wil weten of ook wilt bespreken met zorgverlener



Figuur 6 | Percentage prostaatkankerpatiënten dat een uitkomst alleen wil weten of ook wilt bespreken met zorgverlener



Figuur 7 | Percentage longkankerpatiënten dat een uitkomst alleen wil weten of ook wilt bespreken met zorgverlener

Conclusie:

Uit de resultaten van de vragenlijst maken we op dat de meeste uitkomsten door patiënten als belangrijk worden gezien bij het maken van behandelkeuzes. Daarnaast maken we op dat de nadruk van het bespreken van uitkomstinformatie kan verschillen tussen verschillende aandoeningen. De prostaat- en

longkankerpatiënten willen graag zowel uitkomsten op het gebied van kwaliteit van leven, als klinische uitkomsten bespreken met hun zorgverlener. IBD-patiënten leggen vooral de nadruk op uitkomsten op het gebied van kwaliteit van leven. Daarnaast hoeft deze patiëntengroep ook niet alle uitkomsten te bespreken met hun zorgverlener, en vinden ze het voldoende om er over geïnformeerd te zijn.

Deze resultaten zullen worden gebruikt voor een wetenschappelijk artikel over het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Voor dit onderzoek hebben we ook zorgverleners geïnterviewd. We verwachten dit artikel in 2023 te kunnen publiceren.

Dankwoord:

We willen graag de volgende patiëntenverenigingen en organisaties bedanken voor hun hulp bij het uitzetten van de vragenlijst: Kanker.nl, Crohn & Colitis NL, Prostaatkankerstichting, Stichting DUOS en Longkanker Nederland. Daarnaast willen we graag alle respondenten bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek.

Literatuur:

Santeon. (2020). *Samen Beter*. Gevonden op: <https://santeon.nl/onze-aanpak/samen-beter/>

van der Nat, P., & Garvelink, M. (2021). Patiëntparticipatie verdient centrale rol in transitie naar waardegedreven zorg. Gevonden op Qruux website: <https://www.qruux.com/patientparticipatie-verdient-centrale-rol-in-transitie-naar-waardegedreven-zorg/>